

FUNCIONAL

O que ele FAZ

ABVD (autocuidado)

Katz (0-6) · Barthel (0-100): 100 independente · <20 dependência total

AIVD (comunidade) — caem 1º

Lawton (9-27): 25-27 indep. · Pfeffer (informante): ≥6 comprometido

Mobilidade / quedas

TUG ↑ (~≥12-20 s) · SPPB · Tinetti. Queda no último ano = red flag

NUTRICIONAL

O que ele COME

Rastreio: MAN/MNA

≥24 normal · 17-23,5 risco · <17 desnutrido

Medidas de apoio

Perda ≥5% peso (3-6m) · IMC (corte ↑ no idoso) · panturrilha <31 cm

Não confundir

Desnutrição (pode ter IMC normal) × sarcopenia (força/massa ↓; reversível)

PSICOSSOCIAL

Com QUEM conta

Humor — EGD/Yesavage-15

≤5 normal · ≥7 depressão · ≥11 mod-grave. Atípica: somática/anedonia

Suporte: APGAR da família

> 6 boa · 4-6 disfunção mod. · <3 acentuada

Cuidador / sobrecarga

Vínculo, abuso/negligência · Zarit (sobrecarga) → acionar rede

PROCESSO DA AGA

1. RASTREAR (IVCF-20 / gatilhos)

2. CONFIRMAR (instrumento dirigido)

3. INTERVIR (plano multiprofissional, metas funcionais)

AGA BREVE NO HOSPITAL DE TRANSIÇÃO — a janela perfeita

Paciente estabilizado + tempo de permanência + meta de alta. Vantagens: avalia capacidade real e modificável; direciona a reabilitação; planeja alta segura (↓ reinternação); momento de ouro p/ desprescrição; mede ganho (Barthel/Lawton entrada×saída).

EVIDÊNCIA & ARMADILHA

Evidência (forte): AGA ↑ chance de o idoso estar vivo e EM CASA no seguimento (Cochrane, Ellis 2017). No idoso, desfecho = funcionalidade, não só mortalidade.

Armadilha: medir habilidade declarada (“consigo”) e não o desempenho REAL (“quem faz?”).